

Escopo e Diretrizes do VITTAS 2.0

1. Escopo inicial da plataforma

O VITTAS será uma plataforma digital de integração, acesso e acompanhamento de serviços de saúde, com foco inicial no ecossistema privado e suplementar.

A plataforma terá como objetivo conectar pacientes, instituições de saúde, profissionais e, progressivamente, operadoras de planos de saúde, permitindo centralizar informações relacionadas à oferta e disponibilidade de serviços de saúde.

O VITTAS permitirá que pacientes consultem instituições, serviços, especialidades, profissionais, convênios, horários e disponibilidade de atendimento, além de realizar ou solicitar agendamentos quando essa funcionalidade estiver disponibilizada pela instituição.

A plataforma também permitirá que o paciente acompanhe seus atendimentos e consulte receitas disponibilizadas por instituições ou sistemas integrados, quando essas informações estiverem disponíveis.

O projeto será estruturado como uma camada de acesso, integração, organização e apresentação das informações provenientes das instituições participantes e dos sistemas integrados.

O VITTAS não pretende substituir os sistemas de gestão utilizados pelas instituições. Sua função será atuar como uma camada de integração entre os usuários e esses sistemas.

O MVP será desenvolvido com foco na validação da proposta de valor e da arquitetura de integração, contemplando funcionalidades suficientes para demonstrar o fluxo entre paciente, instituição e plataforma.

2. Público do MVP

2.1 Pacientes

Usuários que procuram serviços de saúde, consultam instituições, verificam disponibilidade, realizam ou acompanham agendamentos e consultam informações de atendimentos e receitas disponibilizadas pela plataforma.

2.2 Instituições de saúde

Clínicas, hospitais e unidades de pronto-atendimento particulares que disponibilizam serviços, profissionais, agendas e informações aos pacientes.

2.3 Administradores do VITTAS

Usuários responsáveis pela administração da plataforma e pelo gerenciamento das instituições, usuários, permissões e recursos disponibilizados pelo sistema.

3. Cadastro e Acesso

O paciente deverá possuir uma conta no VITTAS para utilizar as funcionalidades que dependem de identificação, como realizar e acompanhar agendamentos e consultar informações vinculadas ao seu perfil.

O sistema deverá possuir autenticação para pacientes, instituições e administradores.

O VITTAS deverá possuir diferentes perfis de usuário, com permissões adequadas às suas funções.

Cada usuário deverá acessar somente os recursos permitidos ao seu perfil.

O paciente poderá visualizar seus dados cadastrais, alterar informações permitidas, consultar seus agendamentos, consultar os atendimentos registrados na plataforma, consultar receitas disponibilizadas, visualizar notificações e encerrar sua sessão.

Regras relacionadas: RN01, RN02, RN03 e RN04.

4. Instituições, Serviços e Profissionais

Somente instituições cadastradas no VITTAS poderão disponibilizar serviços, profissionais, agendas e informações aos pacientes.

A instituição deverá estar ativa para que seus serviços e informações sejam disponibilizados aos pacientes.

As informações cadastradas pela instituição serão de responsabilidade da própria instituição.

Todo serviço disponibilizado no VITTAS deverá estar associado a uma instituição.

Os serviços poderão ser associados aos profissionais responsáveis por realizá-los, às especialidades correspondentes e aos convênios ou planos aceitos pela instituição.

Cada instituição poderá disponibilizar informações como:

- Nome;
- Endereço;
- Localização;
- Horário de funcionamento;
- Serviços;
- Especialidades;
- Profissionais;
- Convênios aceitos;
- Formas de atendimento;
- Informações institucionais;

- Disponibilidade de horários, quando aplicável.

A instituição poderá cadastrar e gerenciar seus profissionais, associando-os às especialidades, serviços e horários correspondentes.

O VITTAS não será responsável pela validação ou regulamentação profissional. As informações deverão ser fornecidas e mantidas pelas instituições participantes.

Regras relacionadas: RN05, RN06, RN07, RN08, RN09, RN10 e RN11.

5. Convênios e Planos

O VITTAS permitirá relacionar instituições, serviços e profissionais aos convênios ou planos aceitos.

O paciente poderá utilizar seu convênio ou plano como critério para pesquisar instituições e serviços.

Quando houver integração disponível, informações provenientes da operadora poderão ser utilizadas para auxiliar na identificação de serviços compatíveis.

A apresentação de um serviço como compatível com determinado convênio não significará autorização definitiva para sua realização.

A confirmação de cobertura, autorização ou elegibilidade será responsabilidade da instituição ou da operadora responsável.

Regras relacionadas: RN11, RN12, RN13, RN14 e RN15.

6. Busca de Instituições e Serviços

O paciente poderá pesquisar instituições e serviços disponíveis no VITTAS.

A pesquisa poderá considerar:

- Localização;
- Instituição;
- Serviço;
- Especialidade;
- Convênio ou plano;
- Disponibilidade;
- Modalidade de atendimento.

A localização poderá ser utilizada para apresentar instituições próximas ao paciente.

O VITTAS poderá disponibilizar uma busca orientada na qual o paciente informa o tipo de atendimento ou serviço desejado.

A plataforma poderá cruzar a necessidade informada com os dados estruturados disponíveis, considerando especialidade, serviço, localização, convênio e disponibilidade.

A partir dessas informações, o sistema poderá apresentar alternativas compatíveis.

Regras relacionadas: RN16, RN17 e RN18.

7. Agenda e Disponibilidade

A instituição poderá cadastrar os horários disponíveis para seus serviços e profissionais.

O sistema permitirá:

- Cadastro de horários;
- Alteração de horários;
- Bloqueio de horários;
- Liberação de horários;
- Consulta de disponibilidade;
- Atualização da agenda.

A disponibilidade exibida pelo VITTAS deverá considerar os horários cadastrados pela instituição ou recebidos por integração.

Quando houver integração externa, a disponibilidade poderá ser obtida a partir do sistema da instituição.

A informação apresentada dependerá da atualização da fonte integrada.

Regras relacionadas: RN19, RN20, RN21 e RN22.

8. Agendamento

O paciente poderá realizar ou solicitar um agendamento quando houver disponibilidade para o serviço escolhido e quando essa funcionalidade estiver disponibilizada pela instituição.

O processo poderá envolver:

- Seleção da instituição;
- Seleção do serviço;
- Seleção do profissional, quando aplicável;
- Seleção do horário;
- Confirmação;
- Registro do agendamento;

- Notificação ao paciente;
- Atualização do status.

Após a realização do agendamento, o sistema deverá registrar as informações necessárias para seu acompanhamento.

A instituição poderá visualizar e administrar os agendamentos realizados pela plataforma.

O paciente poderá cancelar um agendamento quando essa funcionalidade estiver disponível para o serviço.

O paciente poderá reagendar um atendimento quando essa funcionalidade estiver disponível.

O status do agendamento poderá ser atualizado conforme as ações realizadas pelo paciente, pela instituição ou por sistemas integrados.

Regras relacionadas: RN23, RN24, RN25, RN26, RN27 e RN28.

9. Acompanhamento dos Atendimentos e Receitas

O paciente poderá consultar seus agendamentos registrados no VITTAS.

Também poderá consultar os atendimentos registrados na plataforma.

O acompanhamento poderá apresentar informações administrativas disponíveis sobre o atendimento, como:

- Data;
- Horário;
- Instituição;
- Profissional;
- Serviço;
- Status.

Quando uma instituição ou sistema integrado disponibilizar uma receita vinculada a um atendimento do paciente, o VITTAS poderá permitir sua consulta e visualização.

As receitas disponibilizadas poderão apresentar informações como:

- Data de emissão;
- Instituição;
- Profissional responsável;
- Identificação do atendimento relacionado;
- Medicamentos ou itens prescritos;

- Orientações fornecidas na receita;
- Documento digital, quando disponibilizado pela fonte integrada.

O VITTAS poderá manter um histórico das receitas disponibilizadas ao paciente, permitindo sua consulta posteriormente.

A receita deverá ser apresentada conforme as informações fornecidas pela instituição ou sistema de origem.

O VITTAS não será responsável pela emissão, alteração, validação clínica ou prescrição dos medicamentos.

O MVP não terá como objetivo disponibilizar um prontuário clínico completo nem substituir sistemas de prescrição utilizados pelos profissionais e instituições.

Regras relacionadas: RN29, RN30, RN31, RN33, RN34, RN35, RN36 e RN38.

10. Notificações

O sistema deverá possuir um mecanismo de notificações relacionadas aos agendamentos.

Poderão ser disponibilizadas notificações relacionadas a:

- Confirmação de agendamento;
- Cancelamento;
- Reagendamento;
- Alteração de horário;
- Lembrete;
- Alteração de status.

No MVP, poderão ser priorizados mecanismos como notificações internas e e-mail.

Integrações com outros canais poderão ser implementadas posteriormente.

Regra relacionada: RN32.

11. Portal da Instituição

O VITTAS disponibilizará uma área administrativa específica para as instituições participantes.

A instituição poderá administrar as informações utilizadas para disponibilização de seus serviços aos pacientes, incluindo:

- Dados cadastrais;
- Endereço;

- Unidades;
- Horários;
- Contatos;
- Serviços;
- Especialidades;
- Convênios;
- Profissionais.

A instituição poderá cadastrar e gerenciar profissionais, serviços, horários e agendamentos conforme as regras estabelecidas pelo sistema.

As informações disponibilizadas aos pacientes serão de responsabilidade da própria instituição.

Quando aplicável, a instituição ou sistema integrado poderá disponibilizar receitas e informações relacionadas aos atendimentos para consulta pelos pacientes.

Regras relacionadas: RN05, RN06, RN07, RN08, RN09, RN10, RN11, RN19, RN20, RN21, RN25 e RN38.

12. Painel Administrativo do VITTAS

O VITTAS possuirá recursos administrativos destinados aos usuários com perfil de administrador.

O painel permitirá o gerenciamento dos recursos compatíveis com as permissões do administrador, incluindo instituições cadastradas, usuários, perfis de acesso e informações necessárias à operação da plataforma.

As instituições poderão ser disponibilizadas ou retiradas da plataforma conforme seu status de cadastro e ativação.

O acesso às funcionalidades administrativas deverá respeitar os perfis e permissões definidos pelo sistema.

Regras relacionadas: RN02, RN03, RN04, RN05 e RN06.

13. Integração e Interoperabilidade

A interoperabilidade será um dos principais diferenciais técnicos do VITTAS.

O sistema será estruturado para funcionar como uma camada intermediária entre usuários e sistemas das instituições.

A arquitetura deverá permitir fluxos como:

Sistema da instituição → API → VITTAS → Paciente

e:

Paciente → VITTAS → API → Sistema da instituição

O MVP deverá possuir uma camada de integração capaz de se comunicar com sistemas externos.

Deverá ser desenvolvida uma API própria e uma estrutura de integração que permita demonstrar o intercâmbio de dados entre o VITTAS e pelo menos uma fonte externa ou ambiente simulado.

A arquitetura deverá contemplar:

- APIs REST;
- Autenticação;
- Autorização;
- Validação de dados;
- Padronização das informações;
- Tratamento de erros;
- Registro de operações;
- Controle de acesso;
- Versionamento das APIs.

As informações provenientes de instituições ou sistemas externos deverão ser apresentadas de acordo com os dados fornecidos por essas fontes.

A disponibilidade e atualização das informações integradas dependerão da disponibilidade e atualização dos sistemas de origem.

Quando uma fonte externa não fornecer determinada informação, o VITTAS não deverá apresentá-la como confirmada.

O VITTAS atuará como uma camada de acesso, integração, organização e apresentação, sem substituir os sistemas responsáveis pela operação das instituições.

Integrações reais com sistemas hospitalares ou operadoras dependerão da disponibilidade técnica e autorização dos respectivos fornecedores.

As receitas disponibilizadas por sistemas externos deverão ser tratadas como informações provenientes da fonte de origem, não sendo alteradas pelo VITTAS.

Regras relacionadas: RN33, RN34, RN35, RN36, RN37 e RN38.

14. Segurança e Controle de Acesso

O MVP deverá possuir mecanismos de autenticação, perfis e permissões compatíveis com os diferentes tipos de usuários da plataforma.

O acesso aos recursos deverá ser controlado de acordo com o perfil do usuário.

A arquitetura deverá contemplar mecanismos de autenticação e autorização necessários ao funcionamento das APIs e dos diferentes módulos da plataforma.

O VITTAS deverá considerar princípios de segurança e proteção de dados, especialmente por poder lidar com dados pessoais e, futuramente, dados relacionados à saúde.

O desenvolvimento deverá considerar a legislação brasileira aplicável, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O acesso às receitas deverá ser restrito ao paciente ao qual a informação pertence e aos usuários institucionais autorizados conforme suas permissões.

Regras relacionadas: RN02, RN03, RN04, RN33, RN37 e RN38.

15. Arquitetura e Requisitos Técnicos

A arquitetura deverá priorizar modularidade, escalabilidade e capacidade de integração.

O sistema deverá possuir, no mínimo:

- Frontend web;
- Backend;
- API;
- Banco de dados;
- Sistema de autenticação;
- Módulo administrativo;
- Módulo institucional;
- Módulo do paciente;
- Camada de integração;
- Sistema de notificações;
- Módulo de consulta de atendimentos e receitas.

A arquitetura deverá permitir evolução progressiva da plataforma e integração com diferentes sistemas externos.

A tecnologia específica deverá ser definida de acordo com os conhecimentos da equipe, requisitos de implantação, custos e capacidade de manutenção.

16. Não Escopo do MVP

Para manter o desenvolvimento dentro do limite aproximado de 1.000 horas, os seguintes recursos não farão parte da primeira versão.

16.1 Gestão clínica

Não serão desenvolvidos:

- Prontuário eletrônico completo;
- Emissão de prescrição médica;
- Criação ou alteração de receitas pelo VITTAS;
- Evolução clínica;
- Gestão de medicamentos;
- Diagnóstico;
- Laudos;
- Histórico clínico completo;
- Gestão hospitalar.

A consulta e o armazenamento de receitas disponibilizadas por instituições ou sistemas integrados não serão considerados gestão clínica ou prescrição pelo VITTAS.

16.2 Inteligência artificial clínica

Não será implementada IA para:

- Diagnóstico;
- Prescrição;
- Classificação de risco;
- Decisão médica;
- Definição automática de tratamento;
- Encaminhamento clínico.

16.3 Emergência operacional

Não fará parte do MVP:

- Gerenciamento de ambulâncias;
- Despacho de equipes;
- Rastreamento operacional de ambulâncias;
- Comunicação avançada entre ambulância e hospital;

- Roteamento automático de emergência;
- Seleção automática de hospital de destino.

16.4 Telemedicina

Não serão desenvolvidos inicialmente:

- Consultas por vídeo;
- Prescrição digital pelo VITTAS;
- Plataforma própria de telemedicina;
- Gestão de teleconsultas.

16.5 Financeiro

Não serão contemplados:

- Pagamentos;
- Cobranças;
- Faturamento;
- Gestão financeira;
- Processamento de convênios;
- Glosas;
- Conciliação financeira.

16.6 Operadoras

Não será realizada inicialmente uma integração ampla com múltiplas operadoras de planos de saúde.

Também não será responsabilidade do VITTAS garantir autorização definitiva ou cobertura de procedimentos.

16.7 Integrações complexas

Não será requisito do MVP integrar simultaneamente diferentes ERPs, HIS, prontuários eletrônicos ou sistemas proprietários de diversos fornecedores.

A arquitetura será preparada para isso, mas as integrações serão implementadas progressivamente.

17. Planos Futuros

Fase 2 - Expansão da Interoperabilidade

A evolução poderá contemplar:

- Integração com diferentes sistemas hospitalares;
- Integração com clínicas;
- Integração com laboratórios;
- Integração com operadoras;
- Sincronização avançada de agendas;
- Consulta de cobertura;
- Integração com diferentes padrões e APIs de saúde.

Fase 3 - Emergência e Ambulâncias

Poderão ser implementados:

- Módulo de emergência;
- Cadastro de ocorrências;
- Geolocalização;
- Rastreamento de ambulâncias;
- Roteamento;
- Comunicação entre equipe de emergência e hospital;
- Compartilhamento antecipado de informações;
- Apoio à definição de unidade de destino.

O VITTAS deverá atuar como ferramenta de apoio, sem substituir a avaliação dos profissionais responsáveis.

Fase 4 - Inteligência de Atendimento

Poderão ser implementados:

- Estimativa de tempo de espera;
- Análise de demanda;
- Identificação de unidades alternativas;
- Previsão de disponibilidade;
- Dashboards avançados;
- Análise de indicadores;
- Recomendações baseadas em dados.

Fase 5 - Inteligência Artificial

Recursos de IA poderão ser utilizados para funções não clínicas ou de apoio, como:

- Busca semântica;
- Assistente de navegação;
- Organização de informações;
- Análise de demanda;
- Predição de ocupação;
- Apoio administrativo.

Qualquer aplicação clínica deverá ser submetida a requisitos específicos de segurança, validação e regulamentação antes de utilização.

Fase 6 - Expansão dos Serviços

O VITTAS poderá incorporar:

- Exames;
- Cirurgias;
- Internações;
- Procedimentos;
- Laboratórios;
- Farmácias;
- Telemedicina;
- Acompanhamento pós-atendimento;
- Serviços domiciliares.

18. Limites e Premissas do Projeto

O funcionamento do VITTAS dependerá da qualidade, disponibilidade e atualização das informações fornecidas pelas instituições e sistemas integrados.

A plataforma não poderá garantir que uma informação externa esteja disponível ou atualizada quando a fonte responsável não fornecer os dados adequadamente.

Informações de disponibilidade, cobertura, agenda, atendimento e receitas deverão ser apresentadas de acordo com os dados disponíveis no momento da consulta.

Quando uma fonte integrada não fornecer determinada informação, o VITTAS não deverá apresentá-la como confirmada.

A apresentação de informações relacionadas a convênios, disponibilidade ou serviços não deverá ser interpretada como autorização definitiva ou garantia de cobertura.

As receitas apresentadas no VITTAS deverão corresponder às informações fornecidas pela instituição ou sistema de origem. O VITTAS não deverá alterar seu conteúdo ou assumir responsabilidade pela decisão clínica relacionada à prescrição.

O VITTAS não deverá ser considerado, por si só, uma fonte definitiva de autorização de procedimentos, diagnóstico, classificação clínica, prescrição ou decisão médica.

A responsabilidade pelas informações cadastradas pelas instituições continuará pertencendo às próprias instituições.

A responsabilidade pelos processos assistenciais continuará pertencendo às instituições e profissionais habilitados.

19. Resultado Esperado do MVP

Ao final das aproximadamente 1.000 horas de desenvolvimento, espera-se que o VITTAS possua uma versão funcional capaz de demonstrar o ciclo principal da plataforma:

Paciente → Busca → Serviço → Instituição → Convênio → Disponibilidade → Agendamento → Acompanhamento → Receita

Paralelamente:

Instituição → Cadastro → Serviços → Profissionais → Convênios → Agenda → Agendamentos → Atendimentos → Receitas

E, tecnicamente:

Sistema externo → API → Camada de integração → VITTAS → Usuário

Dessa forma, o MVP não será apenas um protótipo visual, mas uma primeira versão funcional capaz de validar tanto a proposta de valor quanto o principal diferencial tecnológico do VITTAS: a integração e centralização da experiência de acesso aos serviços de saúde sem substituir os sistemas responsáveis pela operação das instituições.

A funcionalidade de receitas será limitada à consulta e ao histórico de documentos e informações disponibilizados pelas instituições ou sistemas integrados, mantendo fora do escopo a prescrição, alteração ou validação clínica pelo VITTAS.